

分化,故可在下述诸方面加以应用。①用IL-3刺激骨髓形成,可考虑用于治疗再生障碍性贫血、药物和放射线所致的骨髓形成能力低下。②骨髓移植时,应用IL-3可使移植骨髓细胞中的造血干细胞数目增多。即在自身或同种移植时,把移植的骨髓和IL-3共同培养数日,使干细胞增加后再移植。这样,移植时可少取一些骨髓,使移植术简便易行。移植后给予IL-3,可能促进移植后造血功能的恢复。③如果人的IL-3得以分纯,进而制备抗IL-3抗体的话,将对急性白血病等骨髓增殖性疾病的治疗更有实用价值。

精神药物的药物相互作用

李程(佳木斯市神经精神病医院药局)

提要 本文论述了精神药物之间以及与镇静、抗癫痫药,麻醉镇痛药,利尿药,拟肾上腺素药及其它药物之间因配合使用而产生的有益效应或不良反应。

关键词 精神药物;药物相互作用;镇静药;抗癫痫药;麻醉镇痛药

精神药物主要作用于中枢神经系统〔1〕,其治疗疾病的特点,在于调整异常的精神活动,使紊乱的思维、情绪和行为等恢复常态。临床上常与一些药物配伍,产生对治疗有益的效应或不良反应,本文拟就这方面问题以及药物应用于机体后的药物代谢动力学和药效学的影响,从理论上及实践上分别作一阐述。

1 精神药物之间的配伍

目前在临床上最广泛应用的抗精神病药氯丙嗪,与抗躁狂药碳酸锂(简称锂盐)配合应用时,由于锂盐可降低氯丙嗪的血浆浓度,故可影响氯丙嗪的疗效。氯丙嗪、氟哌啶醇、奋乃静与三环类抗抑郁药合用,可以引起丙咪嗪从尿中排泄量减少,因此在人体中,抗精神病药可阻滞三环类抗抑郁药的代谢,并可增加抗胆碱能方面的副作用,容易诱发癫痫。对伴有显著激越的抑郁症病人,可白天应用抗抑郁药,如阿米替林,睡前服氯丙嗪等具有较强镇静作用的抗精神病药,俟激越症状控制后,则减少或停用抗精神病药〔2〕。有些忧郁病人用丙咪嗪后可转为躁狂状态,有些引起幻觉妄想。这时可加用吩噻嗪类而不会影响其抗抑郁疗效。

吩噻嗪类与三环类抗抑郁药在肝脏中竞争相同代谢酶,故降压作用可相互加强,此外二者合用可使原先单一药物引起的室性心动过速明显增加。氟哌啶醇与锂盐并用,可出现严重的脑损害症状,表现为发热、昏睡、意识障碍、全身肌肉僵直、震颤与共济失调等小脑症状。并且可伴有白细胞增高,空腹血糖及血氨增高等。三环类抗抑郁药之间丙咪嗪与阿米替林,丙咪嗪与多虑平,阿米替林与多虑平等为常用的联合应用方式。该药在单独应用时对单相或双相抑郁症均可有效。只有当单独用药无效或疗效欠佳时,才采用联合用药的方式。一般认为联合可使药物产生协同作用,但副作用亦随之加重。除嗜睡、无力、口干,食欲减退外,也可能出现吞咽困难等症状,应予注意。三环类抗抑郁药与单胺氧化酶抑制药(MAOI)联合应用时应注意以下几点:①避免同时应用升压药、鼻粘膜收缩药或吗啡类药物;②只能口服给药;③避免使用效应强大的MAOI,一般用苯乙肼或异唑肼;④三环类以阿米替林较安全,避免使用丙咪嗪、去甲咪嗪及氯丙

咪唑；⑤治疗时两种药物可同时开始或先用三环类，绝不可先用MAOI；⑥两种药物都应该减低剂量，切忌用原来剂量或大剂量〔3〕。两药的相互作用，对伴有明显焦虑，食欲减退和体重减轻的抑郁症病人，疗效更佳。两者之所以有效，因为MAOI可以防止“游离”在神经细胞内的生物胺免受破坏，三环类能抑制中枢神经受体部位有活力的NE和5-HT的再吸收，从而使受体部位的神经介质增加〔4〕。

2 与镇静、抗癫痫药的配伍

吩噻嗪类、三环类抗抑郁药，MAOI及其治疗剂量的锂盐都可增加巴比妥类药物对中枢神经系统产生的抑制作用，延长睡眠时间，呼吸减慢，降低麻醉阈，故在接受抗精神病药物治疗的患者中，巴比妥类宜小剂量使用。同时巴比妥类，导眠能属于药酶诱导剂，可促进抗精神病药的代谢，使其作用降低。巴比妥类还可通过诱导肝微粒体酶而加速三环类抗抑郁药的代谢，因而同时服用巴比妥类可减弱治疗量三环类药物的作用。抗精神病药可降低抽搐的阈值，诱发抽搐发作，故使用抗癫痫药的病人，应注意剂量的调整。

3 与麻醉镇痛剂的配伍

氯丙嗪与哌替啶、异丙嗪组成人工冬眠合剂应用于临床，其中氯丙嗪有加强哌替啶的镇痛、镇静、呼吸抑制及血管舒张作用。氯丙嗪、氟哌啶醇等抗精神病药物均能对抗吗啡、去水吗啡的呕吐反应〔5〕。奋乃静、三氟啦嗪等与麻醉镇痛剂合用，则应减量给予，因其镇痛、镇静和呼吸抑制作用相加或协同。三环类可增加吗啡的镇痛作用和增加哌替啶的抑制呼吸作用，二者合用应减少后者的剂量。MAOI与哌替啶、实可芬类合用，可产生高血压危象，在先给MAOI处理的动物身上，再给哌替啶、吗啡、镇痛药可增加死亡率，致昏迷、低血压、呼吸抑制。机理可能系MAOI损害了肝内使麻醉镇痛药分解的酶，引起脑内游离麻醉剂浓度升高所致。故在接受MAOI药的患者必须用麻醉剂时，只给吗啡常量的1/4—1/5注意生命指征的变化和意识水平，千万不可用哌替啶，因副反应不能预测。

4 与利尿药的配伍

吩噻嗪类及三环类抗抑郁药等可引起体位性低血压，与利尿药（双氢克尿噻）配合使用，可加强利尿药的作用，导致体位性低血压的危险加重，起相加降压作用，应予慎重。如利尿药和泰尔登作用时，后者可加强前者的利尿降压作用。此外利尿剂可引起低血钾，加重甲硫达嗪对心脏的毒性作用。碳酸锂与利尿剂配伍时，前者可减少肾小球对钠的重吸收，并引起腹泻和出汗，故不宜联用。锂盐的排泄几乎完全经过肾脏，体内钠的平衡与肾脏对锂的清除有明显关系，锂的清除受肾小球滤过的影响。噻嗪类利尿药可纠正锂盐引起的肾原性尿崩症状，但因钠丧失，则导致锂的清除率降低，即可能产生锂盐的蓄积而引起中毒。故对正接受锂盐治疗的患者不应投予利尿药。

5 与拟肾上腺素药的配伍

吩噻嗪类药物氯丙嗪与肾上腺素合用时，可使后者升压作用翻转为降压作用，使血压更加下降。这是由于肾上腺素具有兴奋 α 和 β 肾上腺素能受体作用。因此，氯丙嗪引起的降压，不能用肾上腺素纠正而应用去甲肾上腺素或麻黄碱〔7〕。三环类抗抑郁药可明显增强直接作用的拟肾上腺素药（去甲肾上腺素、肾上腺素、新福林）升压反应明显增强，甚至出现高血压危象，高热、大汗、严重头痛，颅内出血或死亡，应避免同时应

用, 这些药物有丙咪嗪、去甲丙咪嗪、去甲替林等。原因是: 三环类阻止单胺重吸收, 或使突触后膜产生过敏。如出现上述症状, 可给肾上腺素能阻断剂及对症处理。三环类抗抑郁药可使阻止间接作用的拟交感胺在突触上重吸收, 阻断升压作用, 若已进入突触前神经元, 则三环类与苯丙胺和哌醋甲酯增强升压作用。三环类抗抑郁药可通过阻止已释放的拟交感胺在突触上的重吸收, 而增加或延长其药理作用。

6 与其它药物的配伍

有人报道, 碳酸锂与四环素并用, 会产生严重的相互作用, 出现疲倦, 言语不清, 极度口渴及双手细微震颤等轻度锂中毒症状。丙咪嗪和阿米替林与L-多巴联用对伴有轻度运动障碍和强直的震颤麻痹症病例疗效显著, 能增强L-多巴对运动障碍和强直的改善, 减轻忧郁症状, 但这类药物可增加L-多巴的心血管反应, 此外丙咪嗪的抗胆碱作用还可能减少L-多巴的胃肠道吸收及代谢物的排泄, 使其疗效降低, 副作用增加。丙咪嗪与性激素合用于女性抑郁患者则抗抑郁作用消失, 男性亦是如此, 且出现妄想症状, 性激素停用后, 妄想症状消失。雌激素与丙咪嗪合用, 不但降低作用, 还出现毒性反应, 恶心、呕吐、持续头痛、嗜睡、低血压、人格解体、粗大震颤等。有一患者服用阿米替林75mg/d, 痢特灵0.3g/d, 2d后出现幻听, 视力模糊, 大汗, 躁动不宁等, 停药后精神症状逐渐消失。又如痢特灵的用药超过5d, 将产生MAOI抑制作用, 因而此药与MAOI合用时, 应仔细观察患者。含胍的MAOI可引起低血糖, 故与胰岛素合用可致低血糖加深或延长, 恢复延续, 忌用! 据报道当用锂盐1.5g/d的一患者, 在接受外科手术用琥珀酰胆碱150mg, 术后呼吸停止4h, 故接受锂盐治疗的患者中, 须手术时应慎重。许多报道认为杨酸毒扁豆碱对于三环类抗抑郁药的抗胆碱作用来讲, 是一种特效解毒剂。毒扁豆碱拮抗多虑平中毒的机理尚不完全清楚, 可能是抑制胆碱酯酶活性, 而且毒扁豆碱易于透过血脑屏障, 使脑内乙酰胆碱浓度升高〔*〕。

参考文献

1. 张继志: 药学报 1986; 21(10): 579
2. 陈至刚等主编: 精神药物的临床应用和副作用 北京 人民卫生出版社 1982; 164
3. 张明圆: 中华神经精神科杂志 1980; 13(3): 188
4. 蔡能: 国外医学精神病学分册 1980; 7(3): 134
5. 王晴川等主编: 药理学 人民卫生出版社 1979; 84
6. 陈思训: 药学报 1986; (11): 617
7. 刘国卿等主编: 药理学 人民卫生出版社 1979; 61
8. 樊德厚: 药学报 1986; (7): 435

浅谈医院院内感染的防制

陈承英(佳木斯铁路分局卫生科)

随着我国医疗卫生事业的发展, “患者至上、质量第一”已成为医院工作的中心。在诊疗过程中如何防止和消除对患者的医源性损害, 采取高效疗法, 减少痛苦、缩短疗程, 是医疗工作面临的一个新课题。对患者的诸种医源性损害则以医院内感染为最重要, 因此已被广大医务人员所关注。现就如何防止和消除“院内感染”, 谈一谈本人认